PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS COVID-19

ANO 2020

Rio Brilhante/MS
Março/2020

DONATO LOPES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIO GREI ALVES VIDAL DE FIGUEIREDO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

ALINI DE OLIVIERA

ENFERMEIRA

SUMÁRIO

I – Introdução **04**

II – Objetivos **05**

III – Situação Epidemiológica no Brasil **06**

IV– Características Gerais sobre a Infecção Humana por COVID-19 **07**

V– Diagnóstico Laboratorial **11**

VI – Medidas de Prevenção e Controle **12**

VII – Notificação de Casos **13**

VIII – Assistência Farmacêutica **13**

IX – Considerações Finais **14**

X – Referências Bibliográficas **15**

XI – Anexos **16**

I – INTRODUÇÃO

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa (tipo) de coronavírus que não havia sido identificada antes em seres humanos. Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus.

Os coronavírus estão por toda parte. Eles são a segunda principal causa de resfriado comum (após rinovírus) e, até as últimas décadas, raramente causavam doenças mais graves em humanos do que o resfriado comum. Ao todo, sete coronavírus humanos (HCoVs) já foram identificados: HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, SARS-COV (que causa síndrome respiratória aguda grave), MERS-COV (que causa síndrome respiratória do Oriente Médio) e o, mais recente, novo coronavírus (que no início foi temporariamente nomeado 2019-nCoV e, em 11 de fevereiro de 2020, recebeu o nome de SARS-CoV-2). Esse novo coronavírus é responsável por causar a doença COVID-19.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia.

Em 22 de janeiro de 2020, foi ativado o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o novo Coronavírus (COE-nCoV). A ativação desta estratégia está prevista no Plano Nacional de Resposta às Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde e desde então o Brasil vem desenvolvendo plataformas, protocolos e boletins epidemiológicos para o enfrentamento ao COVID – 19. Em 26 de fevereiro, o Ministério da Saúde anuncia o 1º caso confirmado de coronavírus no Brasil, no Estado de São Paulo, e apuram suspeitas em outros estados.

Desde então, Estados e Municípios têm se organizado para o enfrentamento ao vírus de rápida propagação e infecção. Portanto, neste documento serão definidas medidas de prevenção e controle da pandemia COVID-19, a integralidade das ações na

prevenção e monitoramento da doença, bem como na assistência à saúde da população. As ações a serem implantadas devem promover a assistência adequada ao paciente, vigilância epidemiológica sensível e oportuna, bem como ações de comunicação. Essas diretrizes têm por objetivo auxiliar os serviços de saúde na mitigação dos processos epidêmicos, comunicação de risco e na redução da morbimortalidade por esta doença. As equipes de saúde desenvolvem diversas atividades de rotina, que dão sustentação às ações que serão aplicadas no Plano de Contingência.

II – OBJETIVOS

Objetivo Geral

- Implantar estratégias de enfretamento a pandemia pelo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do município de Rio Brilhante/MS;

Objetivo Específico

- Definir a estratégia de atuação da Secretaria Municipal de Saúde em alinhamento com as definições constantes do Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19);
- Estabelecer resposta coordenada no âmbito do Município em parceria com o Ministério da Saúde;
- Manter Comitê de Gerenciamento de Crise e Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), para gestão coordenada da resposta;
- Adotar medidas para reduzir a morbimortalidade decorrente da disseminação do Coronavírus (COVID-19) no município de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul;
- Estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos padronizados para a resposta ao novo Coronavírus (COVID-19);
- Cumprir com os Decretos Municipais frente ao Coronavírus, emitidos pela Prefeitura Municipal de Rio Brilhante;
- Elaborar relatórios técnicos para análise e monitoramento das ações.

III – SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO BRASIL

De 03 de janeiro a 07 de fevereiro de 2020, o Centro de InformaçõesEstratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) Nacional capturou 85.229 rumores, foram analisados 624 rumores relevantes e, destes, 238 eram específicos sobre infecção humana por Coronavírus. Entre 18 de janeiro a 07 de fevereiro de 2020, a Secretaria de Vigilância em Saúde recebeu a notificação de 107 casos para investigação de possível relação com a Infecção Humana por Coronavírus. Todas as notificações foram recebidas, avaliadas e discutidas, caso a caso, com as autoridades de saúde dos Estados e Municípios. Em 22 de janeiro foi notificado o primeiro caso suspeito no Brasil que atendia à definição de caso. Dos 107 casos notificados, 34 (32%) atenderam à definição de caso suspeito e 73 (68%) foram classificados como excluídos, por não atenderem à definição de caso, contudo esses casos estão sendo monitorados conforme protocolo da vigilância da Influenza.

Em 26 de fevereiro, o Brasil registrou o primeiro caso confirmado da infecção pelo COVID-19.Trata-se de um paciente do sexo masculino, 61 anos, residente no estado de São Paulo, histórico de viagem recente para Itália, apresentou febre, tosse, dor de garganta e coriza.

E desde então, até o dia 08 de abril de 2020, foram confirmados 15.927 casos de COVID-19. Nas últimas 24 horas foram confirmados 2.210 novos casos da doença, o que representou um incremento de 16% (2.210/13.717) em relação ao total acumulado até o dia anterior.

IV – CARACTERÍSTICAS GERAIS DA DOENÇA

Agente Etiológico

Coronavírus é de uma família de vírus que causam infecções respiratórias. **O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19** após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19). O SARSCoV-2 é uma nova cepa que ainda não havia sido previamente identificada em humanos.

Período de Incubação

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), no caso da COVID-19 esse intervalo varia de 1 a 14 dias, geralmente ficando em torno de 5 dias.

Transmissão

As investigações sobre transmissão do novo coronavírus ainda estão em andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por contato está ocorrendo. É importante observar que a disseminação de pessoa para pessoa pode ocorrer de forma continuada.

Alguns vírus são altamente contagiosos (como sarampo), enquanto outros são menos. Ainda não está claro com que facilidade o novo coronavírus se espalha de pessoa para pessoa. Apesar disso, a transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como: gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão; e contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Período de transmissibilidade

O que se sabe é que a transmissibilidade de pacientes infectados por SARSCoV-2 ocorre entre pessoas, em média, 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares sobre o coronavírus (COVID-19) sugerem que a transmissão possa ocorrer,

mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. Até o momento, não há informação suficiente de quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas que uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus.

Manifestações Clínicas

O espectro clínico da infecção por Coronavírus é muito amplo, podendo variarde um simples resfriado até uma pneumonia severa. No entanto, neste agravo não está estabelecido completamente o espectro, necessitando de mais investigações e tempo para caracterização da doença. Segundo os dados mais atuais, os sinais e sintomas clínicos referidos são principalmente respiratórios. O paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar. Em uma avaliação recente de 99 pacientes com pneumonia confirmada por laboratório como COVID-19 internados no hospital de Wuhan, a média de idade era de 55 anos e a maioria dos pacientes era do sexo masculino (68%). Os principais sintomas eram febre (83%), tosse (82%), falta de ar (31%), dor muscular (11%), confusão (9%), dor de cabeça (8%), dor de garganta (5%), rinorréia (4%), dor no peito (2%), diarréia (2%) e náusea e vômito (1%). De acordo com o exame de imagem, 74 (75%) pacientes apresentaram pneumonia bilateral, 14 (14%) pacientes apresentaram manchas múltiplas e opacidade em vidro fosco e um (1%) paciente apresentou pneumotórax.

O diagnóstico depende da investigação clínico-epidemiológica e do exame físico. É recomendável que em todos os casos de síndrome gripal sejam questionados: o histórico de viagem para o exterior ou contato próximo com pessoas que tenham viajado para o exterior. Essas informações devem ser registradas no prontuário do paciente para eventual investigação epidemiológica.

Definição de Caso

DEFINIÇÃO 1 – síndrome gripal (SG)

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre*, mesmo que relatada, acompanhada de tosse **OU** dor de garganta **OU** coriza **OU** dificuldade respiratória.

***Na suspeita de COVID-19, a febre pode não estar presente.**

Em crianças: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.

Em idosos: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

DEFINIÇÃO 2 – síndrome respiratória aguda grave (SRAG)

Síndrome Gripal que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto.

Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

Casos confirmados de doença pelo coronavírus (COVID-2019)

Por critério laboratorial

Caso suspeito de SG ou SRAG com teste de:

Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2, influenza ou VSR):Doença pelo coronavírus 2019: com resultado detectável para SARS-CoV2.

Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos): Doença pelo coronavírus 2019: com resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG. Em amostra coletada após o sétimo dia de início dos sintomas.

Por critério clínico-epidemiológico

Caso suspeito de SG ou SRAG com:

Histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.

Caso descartado de doença pelo Coronavírus (COVID-2019)

Caso suspeito de SG ou SRAG com resultado laboratorial negativo para coronavírus (SARS-COV-2) não detectável pelo método de RT-PCR em tempo real), considerando a oportunidade da coleta OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico.

V - DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

Para o diagnóstico laboratorial o espécime preferencial é a secreção da nasoorofaringe (SNF). Considerando novos vírus ou novos subtipos virais em processos pandêmicos, ele pode ser estendido até o 7° dia (mas preferencialmente, até o 3° dia). Orienta-se a coleta de swabs combinado (nasal/oral) em MTV (meio detransporte viral) ou aspirado de nasofaringe. A coleta para COVID-19 segue o mesmoprotocolo para coletas de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave). A amostra deverá ser encaminhada com URGÊNCIA para o LACEN acompanhadas da requisição do GAL, cópia do formulário FormSUScap (preenchido manualmente) e Ficha de Notificação de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

Em casos suspeitos em que houver óbito, deverá ser realizada a coleta das seguintes amostras para o diagnóstico viral e histopatológico:

- Tecido da região central dos brônquios (hilar), dos brônquios direito e esquerdo e da traqueia proximal e distal;

-Tecido do parênquima pulmonar direito e esquerdo;

-Tecido das tonsilas e mucosa nasal.

Para o diagnóstico viral, as amostras frescas coletadas devem ser acondicionadas individualmente, em recipientes estéreis e imersas em meio de transporte viral (caldo triptose fosfato). Imediatamente após a coleta, os espécimes identificados com sua origem tecidual devem ser congelados e transportados em gelo seco.

VI - MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE

As medidas de prevenção e controle de infecção devem ser implementadas pelos profissionais que atuam nos serviços de saúde para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos durante qualquer assistência à saúde realizada.

Os serviços de saúde devem fornecer orientações para todos os profissionais de saúde (próprios ou terceirizados) para a prevenção da transmissão de agentes infecciosos. Todos os profissionais de saúde devem ser treinados para o uso correto e seguro das precauções e dos equipamentos de proteção individual.

Ações realizadas no Âmbito Municipal:

PERÍODO	AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO
MARÇO	- Criação do Comitê de Gerenciamento de crise e enfrentamento ao Coronavírus no município de Rio Brilhante; - Organização do atendimento das equipes de ESF e Hospital frente à pandemia; - Distribuição dos EPI´s necessários.
ABRIL	- Treinamento das equipes para atendimento ao paciente suspeito de COVID-19; - Treinamento para utilização de EPI's; - Reuniões semanais com o Comitê para atualização das informações e revisão das ações implementadas.
MAIO	- Implantação de barreiras sanitárias nos 3 acessos ao município; - Implantação de um local específico para atendimento ao paciente suspeito de COVID-19.
JUNHO	- Testagem em massa.
JULHO/ DEZEMBRO	- Manter as ações de enfrentamento a COVID-19 e implementar se necessário.

VII - NOTIFICAÇÃO DE CASOS

A ficha de notificação encontra-se disponível por meio do link: https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=TPMRRNMJ3D. Reforçamos que a mesma deverá ser preenchida, online, exclusivamente pela URR/CIEVS Campo Grande. Os serviços que atenderem caso suspeito deverão realizar o preenchimento manual da mesma.

VIII - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

- Fazer levantamento de medicamentos para o tratamento de infecção humana pelo coronavírus (COVID-19).
- Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes, a depender da entrega pelas empresas licitadas.
- Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço farmacêutico.
- Monitorar o estoque de medicamentos e a utilização de insumos no âmbito municipal.
- Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme a demanda.

IX - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este é um documento norteador para o início das ações de enfrentamento ao COVID-19, no entanto, vale ressaltar que as ações podem ser modificadas semanalmente ou até mesmo diariamente de acordo com a necessidade e situação epidemiológica do município, pois enfrentamos uma doença nova, e os protocolos de atendimento serão atualizados de acordo com atualizações do Ministério da Saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19.

BRASIL. Ministério da Saúde. Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde. Notificação de casos de doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19).

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria MS nº 356 – Medidas de Enfrentamento ao COVID – 19.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico 05- Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública COVID 19. FIOCRUZ. Fundação Oswaldo Cruz.

OMS. Organização Mundial de Saúde.

OPAS. Organização Panamericana de Saúde. Higienização correta das mãos é fundamental para garantir segurança do paciente.

ANEXOS

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Saúde da Família

Abordagem inicial: Integrante da equipe faz a escuta inicial.
EPI'S: Máscara, luvas, jaleco e touca.

Identificado sintomas gripais: ofertado uma máscara e orientado a higienização das mãos.

Sem sintomas gripais: segue o fluxo normal da unidade.

Recepção: Evitar contato físico e com os documentos, solicitar que o paciente fale o nº do documento. Após a ficha, encaminhá-lo para área reservada, com portas fechas e janelas abertas ou com a distância de no mínimo 1m de outro paciente. EPI: máscara.

Avaliação da enfermagem: Se caso suspeito classificar como prioridade, avisar o médico, usar EPI's indicados pelo Ministério da Saúde para atender caso suspeito, após o atendimento descartar em lixo contaminado.

Triagem: verificar temperatura, PA, peso, altura e saturação (se necessário).

ATENDIMENTO MÉDICO

Seguir protocolo clínico do Ministério da Saúde em caso de suspeita de Corona Vírus.

ANEXO II

FLUXO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Formulário Médico

Identificação Nome:_____ Data de Nascimento:_____

Revisão da história clínica (sintomas de síndrome gripal com ou sem febre). Avaliar outros sinais e sintomas, diagnósticos alternativos, descompensação de comorbidades, etc.

Classificação de gravidade

CASO GRAVE - ESTABILIZAÇÃO ENCAMINHAMENTO PARA CENTRO DE REFERÊNCIA

CASO LEVE – avaliar comorbidades que contraindicam isolamento domiciliar (ver protocolo clínico). Se possível acompanhar na APS, realizar manejo clínico apropriado (medicamentos sintomáticos, prescrever oseltamivir para pessoas com condições de risco para complicações, etc.), orientações de isolamento domiciliar para paciente e contatos da casa e monitoramento de 48/48 horas presencial (conforme necessidade clínica) ou por telefone. Fornecer atestado médico de 14 dias para propiciar o isolamento domiciliar para o paciente (CID 10: J11 - Síndrome Gripal ou B34.2 - COVID-19) e seus contatos da casa (CID 10: Z20.9 - Contato com exposição a doença transmissível não especificada). Anotar informações no prontuário. Observação: Caso a pessoa apresente sinais ou sintomas de gravidade ou comorbidades que contraindiquem o isolamento domiciliar, entrar em contato com seu centro de referência para promover hospitalização. Fornecer atestado quando necessário comprovar ausência (trabalho, escola) e assim propiciar o isolamento domiciliar. Orientar familiares a buscar atendimento ao início de sintomas nos mesmos. Para mais informações, consultar Protocolo de Manejo Clínico.

ANEXO III

FLUXO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Formulário Enfermeiro

Nome:_____ Data de Nascimento:_____

Apresenta sintomas respiratórios (tosse, dor de garganta, falta de ar, esforço ou desconforto respiratório)? ( ) SIM ( ) NÃO

Apresenta ou apresentou febre? ( ) SIM ( ) NÃO

Apresenta outros sinais e sintomas relevantes : ( ) SIM ( ) NÃO

Se sim, descreva: _____

CASO SUSPEITO DE SINDROME GRIPAL? ( ) SIM ( ) NÃO

Avaliação Geral: Apresenta outras comorbidades ? ( ) sim ( ) não

Se sim, descreva: _____

Medicamentos de uso contínuo ( ) sim ( ) não

Se sim, descreva: _____

Apresenta alergias de medicamentos ( ) sim ( ) não

Se sim, descreva: _____

História de cirurgias prévias ou internações recentes ( ) sim ( ) não

Se sim, descreva: _____

Anotar informações em prontuário. Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma preocupante, acione imediatamente o médico (a). Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e direcione para o atendimento do médico(a).

ANEXO IV

FLUXO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Formulário Técnico

Nome:_____ Data de Nascimento:_____

Motivo da consulta:_____

_____

_____

_____

Sinais vitais:

Temperatura axilar (T.ax): _____

Freqüência cardíaca (FC): _____

Freqüência respiratória (FR): _____

Saturação de oximetria (Sat): _____

Pressão arterial (PA): _____

Anotar informações em prontuário. Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma preocupante, acione imediatamente enfermeiro e/ou médico (a). Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e direcione para o atendimento do enfermeiro (a).

ANEXO V

FLUXO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Formulário Agente Comunitário de Saúde/Recepcionista

Nome:_____ Data de Nascimento:_____

Idade:_____ Sexo:_____ Tel/Cel: ( ) _____

Endereço:_____

_____

CPF:_____Cartão Nacional SUS:_____

Motivo de procura da USF:_____

_____

_____

_____

_____

Queixa de sintomas de síndrome respiratória (tosse, dor de garganta, desconforto respiratório com ou sem febre)? ( ) SIM ( ) NÃO

Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios, forneça uma máscara cirúrgica, oriente higienização imediata das mãos/forneça álcool gel, solicite que evite tocar no rosto e em superfícies e direcione para atendimento do auxiliar ou técnico de Enfermagem/Enfermeiro(a) em A sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar condicionado desligado.